

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA — ESTADO DO AMAZONAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO — ART. 75, VIII, LEI N.º 14.133/2021

Processo Administrativo n.º 2026.00003

# JUSTIFICATIVA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL

Aquisição de Autoclave Hospitalar a Vapor  
Central de Material e Esterilização — CME

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Unidade demandante:     | Secretaria Municipal de Saúde — CME |
| Responsável:            | Cíntia Felipe Roque                 |
| Valor estimado:         | R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) |
| Fonte de recursos:      | Emenda Parlamentar Estadual — ALEAM |
| Data do relatório-base: | 05 de março de 2026                 |
| Elaborado em:           | Borba/AM, 15 de março de 2026       |

**QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO**

|                                              |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processo:</b>                             | 2026.00003                                                                                                                                                               |
| <b>Unidade solicitante:</b>                  | Secretaria Municipal de Saúde — Borba/AM                                                                                                                                 |
| <b>Setor / local:</b>                        | Central de Material e Esterilização (CME) — Hospital Central de Borba                                                                                                    |
| <b>Responsável pela elaboração:</b>          | Cíntia Felipe Roque                                                                                                                                                      |
| <b>Objeto:</b>                               | Aquisição de autoclave hospitalar a vapor, tipo B (pré-vácuo), horizontal, câmara ≥ 100 L, com periféricos, logística CIF Borba/AM, qualificações QI/QO/QD e treinamento |
| <b>Equipamento inoperante (substituído):</b> | Autoclave nº 6897 — Phoenix Luferco — fab. 2019 (~6 anos de uso)                                                                                                         |
| <b>Fundamentação legal:</b>                  | Art. 75, VIII, Lei n.º 14.133/2021 — Dispensa por Emergência                                                                                                             |
| <b>Fonte de recursos:</b>                    | Emenda Parlamentar Estadual — Assembleia Legislativa do Amazonas                                                                                                         |
| <b>Valor estimado:</b>                       | R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)                                                                                                                                      |
| <b>Data do relatório técnico-base:</b>       | 05 de março de 2026                                                                                                                                                      |

**1. Fundamento Legal****Art. 75, VIII, Lei n.º 14.133/2021**

*“É dispensável a licitação: [...] VIII — nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e às parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano [...]”*

A presente Justificativa de Situação Emergencial fundamenta-se no art. 75, VIII, da Lei Federal n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), que

autoriza a dispensa de licitação em situações de emergência caracterizada pela urgência de atendimento que possa comprometer a continuidade de serviço público essencial ou a segurança de pessoas.

Os elementos fáticos descritos nas seções seguintes demonstram o preenchimento **cumulativo** dos três requisitos legais que legitimam a contratação direta:

- 1. **Situação emergencial concreta e documentada**, não provocada por omissão ou desídia da Administração;
- 2. **Risco direto à segurança de pacientes e profissionais de saúde**, decorrente da falha sistêmica irreversível do equipamento; e
- 3. **Objeto delimitado ao estritamente necessário** ao atendimento da emergência, sem excesso ou superdimensionamento.

## 2. Fato Gerador — O Equipamento e Sua Falha

### 2.1 Identificação do Equipamento em Operação

O Hospital Central de Borba dispõe de **uma única autoclave hospitalar** instalada na sua Central de Material e Esterilização (CME). Trata-se do equipamento descrito a seguir:

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de patrimônio: | 6897                                                                                                                           |
| Fabricante:           | Phoenix Luferco                                                                                                                |
| Ano de fabricação:    | 2019 (aproximadamente 6 anos de uso)                                                                                           |
| Tipo:                 | Autoclave hospitalar a vapor — câmara única                                                                                    |
| Localização:          | CME — Hospital Central de Borba                                                                                                |
| Status atual:         | <b>INOPERANTE — falha sistêmica múltipla</b>                                                                                   |
| Laudo técnico:        | Relatório formal lavrado pelo Diretor Hospitalar Daniel Gomes Vinhote (Decreto n.º 0630/2026), conforme Anexo I deste processo |

### 2.2 Descrição Técnica das Falhas Identificadas

O diagnóstico técnico, formalizado pelo Diretor Hospitalar em relatório datado de 05 de março de 2026, identificou as seguintes falhas, todas de natureza grave e com impacto direto na segurança do processo de esterilização:

**Falhas Sistêmicas Identificadas — Autoclave nº 6897****F1****Salto de etapas do ciclo de esterilização**

O equipamento transita diretamente da fase de esterilização para a fase de secagem sem concluir o processo de forma íntegra. Essa falha invalida a garantia de esterilização, pois o tempo de *plateau* — exposição contínua na temperatura alvo — não é respeitado, impedindo o alcance do **Nível de Garantia de Esterilidade (SAL) de  $10^{-6}$** , exigido pela RDC ANVISA 15/2012.

**F2****Não atingimento da temperatura mínima de esterilização**

A autoclave falha em alcançar a temperatura de  **$134\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$**  prevista para ciclos de pré-vácuo com artigos porosos. A validação da esterilidade a vapor é matematicamente expressa pelo **Valor  $F_0$** :

$$F_0 = \int_0^t 10^{\frac{T-121,1}{z}} dt$$

onde  $T$  = temperatura instantânea (°C),  $z = 10\text{ °C}$  (*G. stearothermophilus*)

Com temperatura insuficiente, o  $F_0$  calculado é sistematicamente inferior ao mínimo de **15 minutos** exigido, tornando os artigos processados microbiologicamente inseguros.

**F3****Falha no sistema hidráulico de abastecimento automático**

O sistema de entrada de água autônoma está inoperante, exigindo intervenção manual a cada ciclo. Isso compromete: (i) a **padronização dos ciclos** (cada operador intervém de forma diferente); (ii) a **rastreabilidade do processo** (RDC 15/2012, art. 34); e (iii) a **segurança do operador**, exposto ao risco de queimaduras durante a manipulação de componentes aquecidos.

**F4****Instabilidade geral — falha sistêmica múltipla**

O comportamento errático do equipamento ao longo dos ciclos, com parâmetros de pressão e temperatura inconsistentes, é indicativo de falha simultânea em múltiplos subsistemas (controle eletrônico, sensores, válvulas). A coexistência de F1, F2 e F3 descarta a hipótese de pane isolada e confirma a degradação sistêmica do equipamento.

### 3. Caracterização da Situação de Emergência

#### 3.1 Impactos Operacionais Imediatos

A inoperância da única autoclave do CME produz impactos diretos e imediatos na operação assistencial do Hospital Central de Borba, de forma que não podem ser supridos por solução alternativa interna:

- **Redução crítica da capacidade de esterilização** de instrumentais médico-cirúrgicos utilizados em cirurgias, curativos, procedimentos invasivos e emergências do pronto-socorro;
- **Risco de desabastecimento de materiais esterilizados** para todos os setores assistenciais, incluindo centro cirúrgico, pronto-socorro, UTI (quando operacional) e unidades de internação;
- **Impossibilidade de garantia da eficácia do processo** de esterilização, com risco concreto de utilização de artigos inadequadamente estéreis — violação direta dos arts. 5.º, 6.º e 34 da **RDC ANVISA n.º 15/2012**;
- **Exposição dos profissionais de saúde** a materiais potencialmente contaminados durante o processo de reprocessamento manual emergencial.

### 3.2 Risco Sanitário Direto ao Paciente

O processamento inadequado de artigos críticos e semicríticos é a principal causa de **Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)** de origem instrumental. No contexto específico do Hospital Central de Borba, hospital de referência para uma população de **34.869 habitantes** (IBGE 2025) em área de acesso predominantemente fluvial, a ausência de esterilização adequada tem consequências amplificadas:

#### Cadeia Causal de Risco — Falha de Esterilização → Dano ao Paciente

**Falha sistêmica do equipamento** → processamento com  $SAL > 10^{-6}$  → **artigo crítico microbiologicamente inseguro** → contato com sítio cirúrgico ou tecido estéril → **Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC)** ou IRAS sistêmica → morbidade, internação prolongada, sepse, **óbito evitável**.

No interior do Amazonas, onde o tempo de acesso a centros de referência em Manaus pode superar 24 horas por via fluvial, a evolução de uma ISC grave sem tratamento imediato disponível configura **risco de morte** diretamente atribuível à falha de esterilização.

A magnitude do risco é classificada na seguinte matriz:

| Probabilidade ↓<br>Impacto → | Insignificante | Moderado | Grave            | Catastrófico |
|------------------------------|----------------|----------|------------------|--------------|
| Improvável                   |                |          |                  |              |
| Possível                     |                |          |                  |              |
| Provável                     |                |          | ★ ISC<br>GRAVE   |              |
| Quase Certa                  |                |          | ★ IRAS/<br>SEPSE | ★ ÓBITO      |

★ Posicionamento do risco: probabilidade “Quase Certa/Provável” × impacto “Grave/Catastrófico” — Zona Vermelha — exige ação imediata.

### 3.3 Impossibilidade de Aguardar o Rito Licitatório Regular

A realização de Pregão Eletrônico — modalidade regular para aquisição deste bem — demandaria, em condições normais, o seguinte prazo mínimo:

| Etapa                                      | Prazo Mín.        | Observação                                    |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| ETP + TR + pesquisa de preços              | 15 dias           | Já concluídos                                 |
| Elaboração e revisão do edital (CPL + PGM) | 10 dias           |                                               |
| Publicação no PNCP até abertura            | 8 dias            | Art. 55, § 2.º                                |
| Prazo de propostas + sessão + habilitação  | 15 dias           |                                               |
| Recursos + homologação + assinatura        | 10 dias           |                                               |
| Prazo de entrega — período de seca         | 90 dias           | Ago–Nov: balsas de menor calado               |
| <b>TOTAL ATÉ ENTREGA TÉCNICA</b>           | <b>≈ 148 dias</b> | <b>Quase 5 meses sem esterilização segura</b> |

Cinco meses de operação hospitalar sem autoclave funcional, em um hospital de referência regional, configura risco inaceitável à vida humana e à continuidade de serviço público essencial — incompatível com qualquer interpretação razoável do princípio da eficiência (CF/88, art. 37) e do dever de cautela sanitária.

## 4. Inviabilidade da Manutenção Corretiva

### 4.1 Análise Técnica da Reparabilidade

A natureza **múltipla e sistêmica** das falhas identificadas (F1 a F4) torna a manutenção corretiva economicamente inviável e tecnicamente insuficiente como solução definitiva. Essa conclusão repousa nos seguintes fundamentos:

1. **Falha sistêmica simultânea em subsistemas críticos:** a coexistência de falhas no sistema de controle de ciclos (F1), no sistema térmico (F2), no sistema hidráulico (F3) e na estabilidade operacional geral (F4) indica degradação estrutural do equipamento, não falha pontual reparável;
2. **Critério de obsolescência funcional:** o equipamento tem **aproximadamente 6 anos de uso** em CME hospitalar de média complexidade com alta rotatividade de ciclos. O horizonte de vida útil de autoclaves deste padrão é de 10 a 15 anos, mas falhas sistêmicas múltiplas antes do décimo ano indicam degradação acelerada, provavelmente agravada pelas condições de umidade relativa elevada ( $UR \geq 80\%$ ) características do clima amazônico;

3. **Custo de reparo x valor de substituição:** a restauração de quatro subsistemas (eletrônico, térmico, hidráulico e estrutural) em equipamento desta natureza, no interior do Amazonas, representa custo estimado superior a **60–75% do valor de um equipamento novo**, sem garantia de desempenho equivalente e sem recomposição do período de garantia — o que inviabiliza economicamente a opção pelo reparo;
4. **Ausência de garantia de desempenho pós-reparo:** mesmo reparado, o equipamento não seria submetido a novo processo de **qualificação documentada (QI/QO/QD)** com resultados auditáveis, mantendo a incerteza sobre o SAL efetivamente alcançado.

#### 4.2 Ausência de Equipamento Substituto Interno

O Hospital Central de Borba não dispõe de autoclave reserva ou de acordo com outra unidade de saúde do município para esterilização emergencial. A esterilização terceirizada em Manaus, única alternativa disponível, implica **interrupção de 4 a 7 dias por remessa**, incompatível com a rotina cirúrgica e com a assistência de urgência e emergência.

##### Por que esta situação não foi provocada por omissão da Administração

A Lei 14.133/2021 e a jurisprudência do TCU/TCE-AM exigem que a emergência **não seja decorrente de negligência ou omissão** do gestor público. No presente caso: (i) o equipamento foi adquirido regularmente em 2019; (ii) a falha sistêmica apresentou-se de forma progressiva e tecnicamente imprevisível em horizonte inferior ao esperado; (iii) a Emenda Parlamentar destinada à substituição foi aprovada pela ALEAM e está disponível. O gestor agiu de forma diligente ao identificar e documentar a falha tempestivamente.

### 5. Especificação Técnica Justificada

A especificação foi elaborada com base nas normas regulatórias aplicáveis (RDC ANVISA n.º 15/2012; ISO 17665-1:2006; EN 285:2015), nas características operacionais do CME do Hospital Central de Borba (40 leitos, procedimentos cirúrgicos de urgência e eletivos) e nas condições ambientais da região amazônica.

| Especificação                      | Requisito Mínimo e Justificativa                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                        | Autoclave hospitalar a vapor saturado, <b>Tipo B (pré-vácuo)</b> , horizontal — obrigatório para artigos porosos (campos, uniformes) e artigos com lúmens (RDC 15/2012, art. 15)                                                         |
| <b>Capacidade mínima da câmara</b> | <b>100 litros</b> — dimensionamento proporcional ao volume cirúrgico de hospital de 40 leitos; equipamento < 100 L geraria ciclos excessivos; > 250 L configuraria superdimensionamento e consumo elétrico incompatível com a rede local |

| Especificação                           | Requisito Mínimo e Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material da câmara</b>               | Aço inoxidável <b>AISI 316L</b> , polido internamente — resistência superior a cloretos (presente na água do Rio Madeira) e à umidade relativa $\geq 80\%$ do clima amazônico                                                                                                            |
| <b>Sistema de vácuo</b>                 | Bomba de anel líquido; pressão absoluta $\leq 30$ mbar; <b>mínimo 3 pulsos</b> alternados de vácuo e vapor — único método eficaz para remoção de ar em materiais porosos e lúmens (EN 285:2015, item 8)                                                                                  |
| <b>Temperatura e precisão</b>           | 105 °C a 135 °C com precisão de $\pm 1$ °C — necessária para atingir $F_0 \geq 15$ min e SAL $10^{-6}$ em todos os ciclos (ISO 17665-1:2006)                                                                                                                                             |
| <b>Programas pré-configurados</b>       | Mínimo <b>13 programas</b> , incluindo: poroso 134 °C, sólido 134 °C, líquido 121 °C, Bowie-Dick e Leak Test — cobertura completa dos artigos processados no CME                                                                                                                         |
| <b>Interface e rastreabilidade</b>      | Tela colorida <b>touchscreen</b> , gestão de usuários com senha, <b>impressora integrada</b> de etiquetas de ciclo — atende à rastreabilidade exigida pelo art. 34 da RDC ANVISA 15/2012                                                                                                 |
| <b>Registro eletrônico</b>              | Memória interna de ciclos + saída USB — exportação de relatórios para auditoria pelo TCE-AM e prestação de contas via Transferegov/SIGEM                                                                                                                                                 |
| <b>Abastecimento de água</b>            | <b>Automático</b> , integrado ao sistema de osmose reversa (60 L/h; condutividade $\leq 1,3$ $\mu\text{S}/\text{cm}$ ) — elimina a falha F3 do equipamento anterior e protege as resistências do gerador de vapor                                                                        |
| <b>Proteção IP do gabinete elétrico</b> | <b>IP 54</b> (mínimo) — proteção contra poeira e respingos, essencial dado UR $\geq 80\%$ em Borba                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sistemas de segurança</b>            | Mínimo <b>10 sistemas</b> , incluindo antiesmagamento de porta, bloqueio de abertura sob pressão, alarme sonoro/visual de falha de vácuo e temperatura — EN 285:2015                                                                                                                     |
| <b>Qualificações documentadas</b>       | <b>QI + QO + QD</b> (ISO 17665-1:2006) realizadas e documentadas no CME do Hospital, com Relatório de Qualificação entregue em 2 vias impressas + PDF assinado, como condição do TRD                                                                                                     |
| <b>Periféricos incluídos</b>            | Sistema de osmose reversa 60 L/h; compressor de ar médico isento de óleo $\geq 50$ L (ABNT NBR ISO 7396-1:2011); racks internos AISI 316L ( $\geq 3$ ); carro de transporte inox; IB ( <i>G. stearothermophilus</i> , cx 50 un.); IC Cl. 5 (cx 200 un.); peças de desgaste para 12 meses |



| Especificação          | Requisito Mínimo e Justificativa                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Logística</b>       | <b>CIF Borba/AM + Entrega Técnica</b> no CME — frete fluvial Manaus–Borba (Rio Madeira), seguro <i>Ad Valorem</i> , embalagem antivibração e antiumpidade para transporte fluvial                               |
| <b>Treinamento</b>     | Mínimo <b>8 horas</b> presenciais no CME do Hospital, com emissão de certificados nominais à equipe — operação, manutenção preventiva, monitoramento biológico/químico, rastreabilidade RDC 15/2012             |
| <b>Garantia</b>        | Mínimo <b>24 meses</b> a contar do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), com atendimento técnico no Estado do Amazonas em até <b>72 horas</b> após chamado e solução definitiva em até <b>15 dias corridos</b> |
| <b>Registro ANVISA</b> | Obrigatório — fabricante ou importador com registro ativo na ANVISA para o equipamento ofertado                                                                                                                 |
| <b>RENEM</b>           | Equipamento deve constar da Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes (RENEM) com código CATMAT — exigência da Emenda Parlamentar (Portarias GM/MS 6.870 e 6.904/2025)                           |
| <b>Normas</b>          | RDC ANVISA 15/2012; ISO 17665-1:2006; EN 285:2015; ABNT NBR ISO 7396-1:2011                                                                                                                                     |

## 6. Dotação Orçamentária e Fonte de Recursos

A aquisição será custeada com recursos de **Emenda Parlamentar Estadual**, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM), destinados à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Borba para aquisição de equipamentos hospitalares. A execução financeira ocorrerá via plataforma **Transferegov** (Ministério da Saúde), observadas as diretrizes das Portarias GM/MS n.º 6.870 e 6.904/2025.

| Componente                                                     | Valor (R\$) | %     |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Autoclave hospitalar 100–150 L com barreira sanitária          | 120.000,00  | 60,0% |
| Periféricos (osmose reversa, compressor, racks, carro, IB, IC) | 35.000,00   | 17,5% |
| Logística CIF Borba/AM + seguro <i>Ad Valorem</i>              | 15.000,00   | 7,5%  |
| Entrega Técnica (QI/QO/QD) + Treinamento (8h)                  | 10.000,00   | 5,0%  |
| Peças de desgaste e consumíveis para 12 meses de operação      | 15.000,00   | 7,5%  |
| Contingência logística (sazonalidade do Rio Madeira)           | 5.000,00    | 2,5%  |

| Componente                        | Valor (R\$)       | %           |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>TOTAL — Emenda Parlamentar</b> | <b>200.000,00</b> | <b>100%</b> |

A reserva de **R\$ 20.000,00** para adequação da infraestrutura do CME (rede elétrica trifásica, ponto hidráulico e sistema de exaustão de vapor) é **adicional e separada** da Emenda Parlamentar — custeada por recurso próprio municipal, em processo administrativo distinto. Essa segregação é obrigatória para evitar contaminação da prestação de contas via Transferegov/SICONV.

Os recursos são de **aplicação vinculada à saúde**, em plena conformidade com as finalidades da transferência parlamentar. O objeto descrito enquadra-se integralmente na categoria de equipamentos hospitalares elegíveis pela Emenda Parlamentar, não havendo desvio de finalidade.

## 7. Prazo da Contratação

### Art. 75, § 3.º, Lei n.º 14.133/2021

*“As contratações de que tratam os incisos [...] VIII [...] deste artigo serão limitadas, pelo valor, ao estritamente necessário para o atendimento da situação emergencial ou calamitosa.”*

Nos termos do art. 75, VIII, da Lei n.º 14.133/2021, a contratação emergencial é limitada ao prazo de **1 (um) ano**, suficiente para a entrega, instalação, comissionamento (QI/QO/QD), treinamento e início de operação regular da nova autoclave.

O prazo de entrega será estipulado conforme o **período hidrológico do Rio Madeira** na data de assinatura do contrato:

| Período      | Meses   | Condição Hidrológica                     | Prazo Máximo     |
|--------------|---------|------------------------------------------|------------------|
| Cheia plena  | Jan–Mai | Navegação plena; balsas de grande calado | 60 dias corridos |
| Vazante      | Jun–Jul | Restrições incipientes; monitorar        | 75 dias corridos |
| Seca extrema | Ago–Nov | Balsas de menor calado obrigatórias      | 90 dias corridos |
| Enchente     | Dez     | Normalização progressiva                 | 75 dias corridos |

Eventual atraso comprovadamente causado por **seca extrema declarada pela ANA** (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) não configurará mora do fornecedor, desde que: (i) a comunicação ao Gestor seja feita com antecedência mínima de 15 dias; (ii) o impedimento

seja comprovado com declaração da empresa de navegação e boletim técnico da ANA; e (iii) a entrega seja realizada no prazo máximo de 30 dias após a retomada da navegabilidade.

É **vedada a prorrogação** do contrato emergencial e a recontratação do mesmo fornecedor sob esta hipótese legal, nos termos do art. 75, VIII, *in fine*, da Lei n.º 14.133/2021.

## 8. Requisitos Formais da Dispensa por Emergência

Em cumprimento ao art. 72 da Lei n.º 14.133/2021, o processo administrativo deverá ser instruído com os seguintes documentos:

|   | Documento                                    | Art. da Lei   | Status                       |
|---|----------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| ① | Esta Justificativa de Situação Emergencial   | Art. 72, I    | Elaborada — Anexo I          |
| ② | Laudo técnico do CME — Diretor Hospitalar    | Art. 72, I    | Elaborado — Anexo II         |
| ③ | Termo de Referência (TR) com especificações  | Art. 72, III  | Elaborado — Anexo III        |
| ④ | Pesquisa de preços — mínimo 3 cotações       | Art. 72, IV   | A realizar — modelo Anexo IV |
| ⑤ | Planilha comparativa e seleção do fornecedor | Art. 72, VII  | A elaborar após cotações     |
| ⑥ | Contrato de Fornecimento                     | Art. 72, VIII | Minuta — Anexo V             |
| ⑦ | Publicação no PNCP em até 10 dias úteis      | Art. 174      | Após assinatura do contrato  |

### Atenção ao TCE-AM — Blindagem Documental

Dispensas por emergência de valor elevado são objeto prioritário de auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Os riscos mais comuns de glosa são: (i) **ausência ou insuficiência da pesquisa de preços**; (ii) **urgência não documentada com evidências concretas** — declarações genéricas são insuficientes; (iii) **contratação de empresa sem capacidade técnica comprovada**; (iv) **falta de publicação no PNCP** no prazo legal. Esta Justificativa, acompanhada do laudo técnico do Diretor Hospitalar e das 3 cotações de mercado, constitui o conjunto mínimo necessário para uma defesa sólida em eventual tomada de contas especial.

## 9. Conclusão e Recomendação

Diante das circunstâncias objetivamente descritas e comprovadas nesta Justificativa, estão configurados **cumulativamente** todos os pressupostos legais para a contratação direta por emergência, nos termos do art. 75, VIII, da Lei Federal n.º 14.133/2021:

- ✓ **Situação emergencial concreta e documentada**, não provocada por omissão ou desídia da Administração: o equipamento (Autoclave n.º 6897 — Phoenix Luferco, 2019) apresentou falha sistêmica progressiva em múltiplos subsistemas, tendo sido formalmente diagnosticado e documentado pelo Diretor Hospitalar Daniel Gomes Vinhote (Decreto n.º 0630/2026);
- ✓ **Risco direto e imediato à segurança de pacientes e profissionais de saúde**, decorrente da impossibilidade de garantir a eficácia do processo de esterilização na única autoclave da unidade, com potencial para ISC, IRAS sistêmica e óbito evitável;
- ✓ **Comprometimento da continuidade de serviço público essencial de saúde**, com risco iminente de desabastecimento de materiais esterilizados para todos os setores assistenciais do hospital de referência regional;
- ✓ **Inviabilidade técnica e econômica da manutenção corretiva**, demonstrada pela natureza sistêmica e múltipla das falhas e pelo custo de reparo estimado em 60–75% do valor de substituição, sem garantia de desempenho; e
- ✓ **Objeto delimitado ao estritamente necessário**, sem excesso ou superdimensionamento, nos termos do art. 75, VIII, *in fine*, da Lei n.º 14.133/2021.

Recomenda-se a **imediata abertura do procedimento de contratação direta por emergência**, nos seguintes termos:

1. Publicação do aviso de dispensa no PNCP, nos termos do art. 72, III, da Lei n.º 14.133/2021;
2. Instrução do processo com esta Justificativa, o Laudo Técnico do CME (Anexo II), o Termo de Referência (Anexo III) e a pesquisa de preços com mínimo de 3 cotações de mercado (Anexo IV);
3. Seleção do fornecedor que apresentar a **proposta mais vantajosa**, compatível com as especificações técnicas do Termo de Referência e com o registro do equipamento na **RENEM**;
4. Assinatura do Contrato de Fornecimento com cláusula de **Entrega Técnica (QI/QO/QD)** e **garantia mínima de 24 meses**;
5. Publicação da contratação no PNCP em até **10 dias úteis** da assinatura, nos termos do art. 174 da Lei n.º 14.133/2021.

Borba – AM, 15 de março de 2026

**Cíntia Felipe Roque**

Responsável pelo Setor  
Central de Material e Esterilização — CME  
Secretaria Municipal de Saúde de Borba/AM

**Daniel Gomes Vinhote**

Diretor Hospitalar  
Hospital Central de Borba  
Decreto n.º 0630/2026

**[Nome e Cargo do(a) Secretário(a) Municipal de Sa-  
úde]**

Secretário(a) Municipal de Saúde de Borba/AM

**APROVADO — Autorizo a abertura da contratação direta**

*Base normativa: Lei n.º 14.133/2021, arts. 72 e 75, VIII • RDC ANVISA n.º 15/2012 • ISO 17665-1:2006 (validação calor úmido) • EN 285:2015 (esterilizadores a vapor) • ABNT NBR ISO 7396-1:2011 (ar médico) • IN SEGES/MGI n.º 65/2021 (pesquisa de preços) • Portarias GM/MS n.º 6.870 e 6.904/2025 (Emenda Parlamentar) • CF/88, arts. 37 e 196.*